EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 85888
SERVICIO : UTI HSC
FECHA : 2024-06-03 13:32:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: RENE NOLBERTO BUSTOS PARRA			**RUN**	: 10.687.993-1
F.Nac	: 07-02-1966	**Edad**	: 58 AÑOS, 3 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: REQUINOA PJE BRASIL 914			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 0		
Fecha Ingreso	: 2024-05-24	**Fecha Egreso**	: 2024-06-03 13:32:00	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I44.2-BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR COMPLETO.

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Bloqueo AV Completo
- MCP Transitorio (24/05/24 al 29/05/24)
- Implante MCP bicameral (29/05/24)
2. Neumotorax izquierdo iatrogénico
- SEP pleural (30/05/24)
4. Edema Pulmonar Agudo resuelto
5. Insuficiencia Cardíaca congestiva cFEc, compensada
6. Sospecha de Estenosis aórtica

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I44.2-BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR COMPLETO. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes mórbidos poco claros, consulta el 24/05/24 en Servicio de Urgencia de HSC por cuadro de 3 días de evolución de dolor torácico tipo puntada, con tope inspiratorio, asociado a disnea. A su ingreso bradicárrdico, hipotenso, con requerimiento de FiO2 adicional. ECG BAV Completo. Exámenes de laboratorio sin alteraciones metabólica ni electrolítica. Se solicita evaluación por UTI, se inicia BIC de isoproterenol y se indica ingreso para monitorización e instalación de MCP transitorio
En UTI se inicia manejo médico de congestión pulmonar con diuréticos de ASA y se instala sonda de marcapaso vía yugular derecha sin incidentes con buena captura.
Se coordina instalación de marcapaso definitivo, procedimiento que se lleva a cabo el 29.05.24 con posterior profilaxis ATB por 24 hrs, se pesquisó post procedimiento neumotórax izquierdo por lo que el 30.05.24 se instala SEP z izquierda aspirativo con posterior reexpansión. Se retira SEP el 02.06.24 con posterior RxTx de control el 03.06.24 sin reproducción de neumotórax.
Actualmente paciente en buenas condiciones generales, afebril, hemodinamicamente estable, ventilando espontáneo, sin UMA, sin O2 adicional, a la espera de ecocardioTE por EAo en HLHT por lo que se plantea hospitalización domiciliaria a la espera de dicho procedimiento

PLAN DE MANEJO:

- HD/CV: Monitorización invasiva. DVA para PAM 65-70 mmHg. Ecocardiograma TE pendiente (estudio de estenosis Ao), mantener hospitalizado hasta realizar estudio (Puede ser Hodom). Al alta continuar control en Poli MCP HCHM. No descubrir sitio quirúrgico.
- Ventilatorio: FiO2 para saturar > o = 92%. Control Rx torax

- Cirugía: RxTx control
- Infeccioso: Sin conflicto actual.
- Renal: Vigilancia de función renal y ELP. Evitar nefrotóxicos
- Metabólico: Sin conflicto actual, vigilar
- Proporcionalidad Terapéutica: Manejo activo

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Régimen hiposódico
3. Paracetasmol 500 mg 2 comp c/8hrs vo SOS
4. Omeprazol 20 mg 1 comp/día vo
5. Furosemida 40 mg ½ comp/día vo
6. Pendiente ecocardiograma TE
7. KNT Respiratoria
8. Hospitalización domiciliaria

GONZALO EDUARDO VERA TORRES
MEDICO TRATANTE
16497415-4

JEFE SERVICIO